TD5 Identification et organisation des données de santé

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Analyse des données

Pour chaque information, expliquer ce qu'elle apporte à la compréhension de la situation, le besoin éventuellement concerné et ce qu'il reste à rechercher. Une information sociale n'est pas automatiquement un problème : vivre seul ne suffit pas à conclure à l'isolement.

Mobilité et sécurité

Dans le cas proposé, gonarthrose, déambulateur, chutes et logement sans ascenseur doivent être mis en relation. Préciser les circonstances des chutes, les douleurs, les aides disponibles et les capacités réelles pour les escaliers et les transferts.

Nutrition

Le cas mentionne 50 kg pour 1,75 m : IMC = 50 / 1,75², soit environ 16,3 kg/m². Ce résultat justifie une évaluation nutritionnelle : évolution du poids, apports, mastication, déglutition, goûts, accès aux repas et contexte médical.

Élimination et autonomie

Le port d'une protection ne démontre pas à lui seul une incontinence. Rechercher pourquoi elle est portée, la possibilité d'atteindre les toilettes, les transferts et le déshabillage. Distinguer capacité habituelle et aide réellement nécessaire.

MTEVD

Maladie et thérapeutiques : problèmes, antécédents pertinents, traitements et effets. Environnement : logement, entourage et aides. Vécu : perceptions et attentes exprimées. Développement ou devenir : autonomie, priorités et perspectives réalistes. Une rubrique sans donnée doit rester à explorer.

Contradictions du travail fourni

La fréquence des visites de la fille varie entre deux passages du document. Elle doit être vérifiée sur l'énoncé de référence ; aucune fréquence n'est retenue comme certaine dans cette synthèse. Ne pas inventer non plus une hospitalisation non mentionnée.

Grille de raisonnement à réutiliser

Donnée repérée ; intérêt pour la situation ; besoin éventuellement concerné ; information complémentaire à rechercher. Décrire chaque lien avec une phrase. Un manque d'information ne doit pas devenir une affirmation.

Reprendre les données du cas

Le sujet décrit une personne âgée vivant à domicile avec une mobilité diminuée, des chutes et des aides. L'âge situe la personne mais ne prouve pas un besoin perturbé. Le recueil doit préciser le fonctionnement habituel, les difficultés actuelles et les ressources. Ne pas inventer une hospitalisation lorsque l'énoncé n'en mentionne pas.

La gonarthrose bilatérale peut gêner la marche et certains transferts. Rechercher douleur, moments d'apparition, capacité de se lever, besoin d'aide et utilisation effective du déambulateur. Les chutes doivent être décrites par leurs circonstances et conséquences. Le logement sans ascenseur doit être relié à ces capacités, et non simplement recopié dans une colonne sociale.

Les difficultés d'accès aux toilettes peuvent traduire une limitation fonctionnelle. Le port d'une protection ne suffit pas à identifier le mécanisme d'éventuelles fuites. Explorer accès, temps nécessaire, déshabillage, transferts, continence et aide disponible. Une intervention doit répondre à la difficulté retrouvée.

La présence d'un SSIAD et d'une aide à domicile constitue une ressource. Il manque le détail de leurs interventions et leur adéquation aux besoins. Ne pas conclure à une dépendance pour tous les actes au seul motif qu'une aide professionnelle est présente.

Nutrition vécu et environnement

Le poids de 50 kg et la taille de 1,75 m donnent un IMC d'environ 16,3 kg/m². L'interprétation doit tenir compte de l'âge et du contexte. Quantifier la perte de poids, les apports et les difficultés alimentaires. Le faible appétit, l'édentation et les aversions sont des pistes à explorer, pas une explication exhaustive.

Le portage des repas facilite l'accès mais ne prouve pas qu'ils sont consommés. Demander si les repas plaisent, si la texture convient, si la personne peut s'installer et manger et si une aide est nécessaire. Rechercher aussi douleur buccale et difficultés de déglutition selon le contexte.

Le deuil et la vie en solitaire peuvent influencer le vécu. Ils ne prouvent pas une dépression ou un isolement subi. L'activité d'horlogerie devenue difficile doit être mise en relation avec les troubles visuels et les tremblements, mais aussi avec la place de cette activité dans l'identité de la personne.

Écouter la radio peut être un loisir choisi. Il faut demander si cette activité apporte de la satisfaction, quelles autres activités sont souhaitées et quels obstacles existent. Le temps prolongé au fauteuil invite aussi à explorer les capacités de changement de position et l'état cutané.

Rédiger MTEVD et hiérarchiser

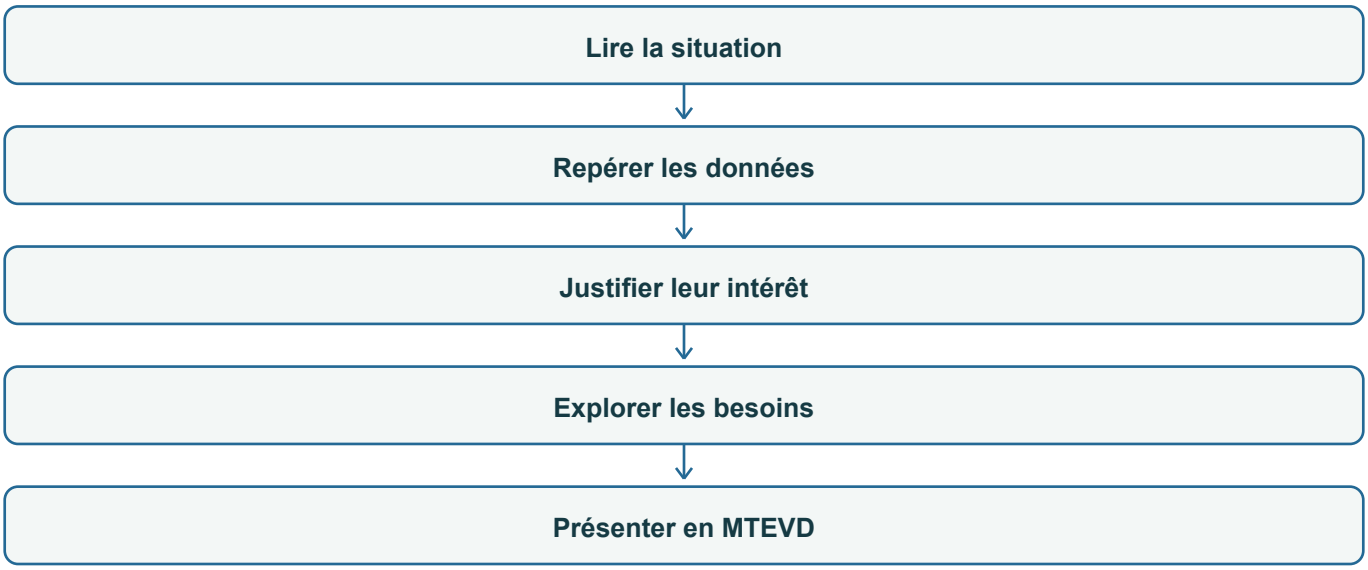
Maladie et thérapeutiques : sélectionner les problèmes et traitements pertinents, leur évolution et leurs effets connus. Environnement : logement, entourage et professionnels. Vécu : ce que la personne exprime et comprend. Développement ou devenir : capacités, dépendances, objectifs et possibilités d’aide. La structure sert à donner du sens et non à remplir toutes les cases par supposition.

Distinguer besoin réellement perturbé, risque et domaine non exploré. Pour la mobilité, les limitations décrites sont des faits ; pour la communication, la satisfaction relationnelle reste à approfondir. La présence d’un facteur de risque ne prouve pas que sa complication est déjà installée.

Une priorité se justifie par la gravité, l’urgence, le retentissement, les souhaits et les possibilités d’action. Fixer un objectif observable : préciser par exemple le niveau d’aide nécessaire pour un transfert, plutôt qu’écrire seulement « améliorer l’autonomie ». Décrire comment l’évolution sera évaluée.

Avant de remettre le travail, contrôler les contradictions, les unités, les calculs et l’absence de jugement. Dans le document transmis, les visites de la fille sont décrites avec des fréquences différentes : ce point doit rester à vérifier. Une synthèse cohérente ne doit pas masquer cette incertitude.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

IMC du cas ? Environ 16,3 kg/m².

Protection = incontinence certaine ? Non.

Une donnée manque dans MTEVD : que faire ? Écrire ce qu'il faut rechercher plutôt qu'inventer.

Sources et portée

UE A1 TD5 Identification et organisation des données de santé.docx

Ressource Moodle correspondante

La contradiction sur la fréquence des visites reste ouverte. Aucune donnée incertaine n'est retenue comme confirmée dans la fiche de révision.